Pramisum



Pramipeksol

Tabletka 0,25 mg va 1,0 mg, №30

Dofamin retseptorlari agonisti (N04BC05)

QISQACHA · **Parkinson va bezovta oyoqlar sindromi. Doza asta titrlanadi; uyquchanlik va impuls nazorati buzilishi haqida ogohlantiriladi.**

Ko'rsatmalar

- Idiopatik Parkinson kasalligi: monoterapiya yoki levodopa bilan ("on-off" fluktuatsiyalarda)
- O'rta va og'ir idiopatik bezovta oyoqlar sindromi (dozasi 0,75 mg gacha)

Dozalash

- Parkinson: sutkalik doza 3 ga bo'linadi; 0,375 mg/sut dan, har 5–7 kunda oshirish
- Keyin har hafta +0,75 mg; maks. 4,5 mg/sut; ≥1,5 mg da uyquchanlik ko'payadi
- Bezovta oyoqlar: 0,125 mg uxlashdan 2–3 soat oldin; har 4–7 kunda oshirish, maks. 0,75 mg
- To'xtatish asta: 0,75 mg/sut dan kamaytirib (birdan to'xtatish — neyroleptik malign sindrom)

Mumkin emas

Pramipeksol yoki komponentga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Ko'ngil aynishi, diskineziya, gipotenziya, uyquchanlik, to'satdan uxlab qolish, gallyutsinatsiya, impuls nazorati buzilishi (qimor, xarid)

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Barcha bosqichlarda samarali; erta bosqichda levodopa samarasiga yaqin
- Levodopaga o'tishni kechiktiradi; levodopa bilan birga bo'lsa levodopa dozasini kamaytirish mumkin
- Kombinatsiya: Konfundus + Pramisum (+ Rekol demensiyada, + Neyrokobal gomotsisteinda)

O'zingizni tekshiring

Bezovta oyoqlar sindromida Pramisum qanday qabul qilinadi?
0,125 mg uxlashdan 2–3 soat oldin, har 4–7 kunda oshirib, maks. 0,75 mg/sut.

Pramisum bilan bemorni nimadan ogohlantirish kerak?
To'satdan uxlab qolish (haydash xavfli) va impuls nazorati buzilishi (qimor, xarid, giperseksuallik).